

Podwójna *diagnoza* — *model*

Uzależnienie + drugie zaburzenie psychiczne. Częste — 50% osób z uzależnieniem, 30% z zaburzeniem psychicznym. Wymaga leczenia jednocześnie obu.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Mueser i wsp. (2003); Drake & Wallach (2000); NIDA Comorbidity Report (2020)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza pojęcie **podwójnej diagnozy** (ang. *dual diagnosis, co-occurring disorders*) — współistnienia uzależnienia z drugim zaburzeniem psychicznym. Pokazuje: 1) **4 wzorce relacji** między zaburzeniami, 2) **najczęstsze kombinacje**, 3) zasadę **zintegrowanego leczenia** (oba jednocześnie, nie sekwencyjnie), 4) gdzie szukać pomocy w Polsce. Karta jest mapą orientacyjną — diagnozę różnicową i konkretne podejście musisz omówić ze specjalistą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Współwystępowanie zaburzeń jest **regułą, nie wyjątkiem**. NIDA (USA, 2020): **50% osób z uzależnieniem** spełnia kryteria innego zaburzenia psychicznego; **30% osób z zaburzeniem psychicznym** ma równoległe uzależnienie. Mueser i wsp. (2003) na podstawie 20-letniej obserwacji pokazali, że **leczenie sekwencyjne** („najpierw uzależnienie, potem depresja”) jest nieskuteczne — 40% pacjentów wraca do używania w pierwszym roku abstynencji, bo nieleczone zaburzenie współwystępujące jest stałym wyzwalaczem. **Leczenie zintegrowane** (oba zaburzenia jednocześnie, ten sam zespół) daje 2x wyższe wskaźniki utrzymania abstynencji w 3-letniej obserwacji.

01

Cztery wzorce relacji między zaburzeniami

1 · SAMOLECZENIE

zaburzenie → uzależnienie

Lęk / depresja / PTSD / ADHD prowadzi do używania jako sposobu radzenia. Przykład: społeczna fobia → alkohol jako odważnik. Khantzian (1985, „hipoteza samoleczenia”).

2 · WYWOŁANIE

uzależnienie → zaburzenie

Długie używanie substancji *wywołuje* zaburzenie. Przykład: amfetamina → psychoza paranoidalna; alkohol → ciężka depresja; sterydy → epizody maniakalne.

3 · WSPÓLNE PODŁOŻE

trzeci czynnik → oba

Wspólne wady genetyczne (impulsywność, polimorfizmy genów), trauma rozwojowa, traumatyczne mózgu — prowadzą równoległe do obu zaburzeń.

4 · WZAJEMNE NASILANIE

zaburzenie ↔ uzależnienie

Oba zaburzenia *nasilają się wzajemnie*. Depresja → picie → wstyd → silniejsza depresja → więcej picia. Klasyczna „*spirala*” podwójnej diagnozy.

U konkretnego pacjenta zwykle obecnych jest **kilka wzorców jednocześnie**. Diagnostyka różnicowa wymaga *czasem 4–6 tygodni abstynencji* — bo niektóre objawy depresji / lęku znikają po odstawieniu, a inne ujawniają się dopiero wtedy.

02 📋 Najczęstsze kombinacje — statystyki

DRUGIE ZABURZENIE	CZĘSTOŚĆ PRZY UZALEŻNIENIU	DOMINUJĄCY WZORZEC
<i>Depresja (MDD)</i>	35-40%	Najczęściej wywoł. / wzajemne nasilanie
<i>Zaburzenia lękowe</i>	30-35%	Samoleczenie
<i>PTSD</i>	20-30%	Samoleczenie + wspólne podłoże
<i>ADHD (dorośli)</i>	15-25%	Samoleczenie + wspólne podłoże
<i>Zab. osobowości</i>	30-50%	Wspólne podłoże (impulsywność)
<i>Choroba afektywna dwubiegunowa</i>	10-15%	Wzajemne nasilanie
<i>Schizofrenia / psychoza</i>	10-50%	Samoleczenie / wywoł. (zwł. po stymulantach)

03 🕒 Zasada zintegrowanego leczenia (IDDT)

IDDT — CO TO ZNACZY

Integrated Dual Disorder Treatment (Mueser i wsp. 2003). **Ten sam zespół terapeutyczny** leczy oba zaburzenia jednocześnie. Pacjent nie krąży między poradnią uzależnień a poradnią psychiatryczną — ma jeden plan terapeutyczny.

DLACZEGO SEKWENCYJNE ZAWODZI

„Najpierw odstaw, potem leczymy depresję” — w abstynencji depresja zwykle **nasila się przez 4-8 tyg.** (efekt protrahowanego odstawienia). Bez leczenia depresji w tym okresie ryzyko nawrotu drastycznie rośnie.

04 ✍️ Moja refleksja — co u mnie

CZY MAM DIAGNOZĘ DRUGIEGO ZABURZENIA?

— *jaką, kiedy, od kogo*

KTÓRY WZORZEC DOMINUJE U MNIE?

— *1, 2, 3 czy 4 z sec. 01*

Klucz: Drake & Wallach (2000, n=210, 10-letnia obserwacja) wykazali, że pacjenci z podwójną diagnozą w programie zintegrowanym mieli **43% trwałej abstynencji + 59% remisji drugiej diagnozy** vs odpowiednio **14% i 19%** w leczeniu sekwencyjnym. Mechanizm: drugie zaburzenie jest *stałym wyzwalaczem nawrotu*, jeśli pozostaje nieleczone. W Polsce IDDT jest niedostępne w klasycznej formie — pacjent zwykle musi krążyć między poradnią uzależnień a psychiatryczną. **Bezpieczny minimum:** jeden lekarz / psychiatra mający przegląd obu, regularna konsultacja z terapeutą uzależnień, leki nie kolidujące z planem abstynencji.